

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Dirección General de Estudios de Postgrado

Facultad de Medicina

Vicedecanato de Investigación y Posgrado



**CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO VILLA CAMPOY, 2025**

PROYECTO DE TESIS

**Para optar el Grado Académico de Magíster en Gerencia en Servicios de
Salud**

Autor

Rosa Verónica PORTILLO VELÁSQUEZ

Asesor

Juan Pedro MATZUMURA KASANO

Lima - Perú

2025

Índice

Índice

I.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:	3
1.1.	Situación Problemática:	3
1.2.	Formulación del Problema:	5
1.2.1.	Problema General:	5
1.2.2.	Problemas Específicos:	5
1.3.	Justificación de la Investigación:	6
1.4.	Objetivos de la Investigación:	7
1.4.1.	Objetivo General:	7
1.4.2.	Objetivos Específicos	7
II.	MARCO TEÓRICO	8
2.1.	Antecedentes del Problema:	8
2.1.1.	Internacionales:	8
2.1.2.	Nacionales:	9
2.2.	Bases Teóricas:	17
2.2.1.	Calidad de la atención:	17
2.2.2.	Satisfacción del usuario:	22
2.2.3.	Trastorno de salud mental:	24
2.3.	Marco conceptuales o glosario:	25
III.	HIPOTESIS Y VARIABLES	27
3.1.1.	Hipótesis General	27
3.1.2.	Hipótesis Específicas:	27
3.2.	Identificación de Variables	28
3.3.	Operacionalización de Variables:	29
3.4.	Matriz de Consistencia	30
IV.	METODOLOGÍA	31
4.1.	Tipo y Diseño de investigación:	31
4.2.	Unidad de análisis:	31
4.3.	Criterios de inclusión y exclusión	31
4.3.1.	Criterios de Inclusión	31
4.3.2.	Criterios de exclusión	31
4.4.	Población de Estudio:	32
4.5.	Tamaño de Muestra	32
4.6.	Selección de Muestra:	32
4.7.	Técnica de Recolección de Datos:	32
4.8.	Análisis e interpretación de la información	35
V.	PRESUPUESTO	36
VI.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	36
VII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
VIII.	ANEXOS	39

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.1. Situación Problemática:

Los trastornos de salud mental son altamente prevalentes, principalmente en países de ingresos medios y bajos; ello impacta en la salud y explican muchas de las inequidades sanitarias existentes. Los desafíos para mejorar los programas y políticas de salud mental se relacionan con abordar los determinantes sociales de la salud. Desde hace más de 50 años se promueve, la implementación de Modelos de Atención Salud Mental Comunitaria lo cual busca pasar del enfoque de hospitales psiquiátricos y especialistas al de redes de servicios, con equipos interdisciplinarios y el rol activo y participativo de la población en el cuidado de la salud mental. (Tafur, S. 2023).

En el 2012 se promulgó la Ley N° 29889 – Ley que modifica el Artículo 11° de la Ley N° 26842 de la Ley General de Salud, y en octubre del 2015 su reglamento. Este marco establece el abordaje comunitario en la atención de la salud mental, dejando atrás la hospitalización; operando solo en los casos que sean estrictamente necesarios. (Antinori Jaén et al., 2022)

La Ley de Salud Mental Ley N° 30947, establece como una de sus finalidades “Garantizar el respeto a la dignidad de las personas con problemas de salud mental o discapacidad, las que gozan de un régimen legal de protección integral y de atención, a través del modelo de atención comunitaria, con continuidad de cuidados, rehabilitación psicosocial y reinserción social”. (Antinori Jaén et al., 2022)

El marco normativo y operativo en salud mental plantea metas concretas, en el mejor de los casos, pero, estas no se monitorean o reportan, siendo una debilidad para evaluar el avance de la reforma, aunado a la línea de base situacional de salud mental desactualizada; a pesar de ser prioridad en la Ley de Salud Mental, no se evalúa o monitorea calidad de la atención, satisfacción del personal de salud, discriminación, estigma, prevención y promoción. Es por ello necesario

la calidad de la atención es decir conocer el grado de armonía entre la expectativa que el usuario tiene en su mente con relación a la necesidad, y la oportuna intervención que permita un mayor beneficio puesto que tener un usuario satisfecho es la esencia del enfoque de la empresa u organización en el cliente, de tal manera esto se logra cuando las expectativas sean iguales o superadas, obteniéndose fidelidad por parte del paciente y su familia. La satisfacción en el área de salud, depende de tres aspectos importantes, el tiempo de espera y ambiente, la atención adecuada y los resultados obtenidos, y la cortesía recibida durante el proceso. Además, la percepción del cliente o usuario se refiere a cómo éste estima que la empresa u organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo con la manera como él valora lo que recibe.

En el campo de la salud mental son escasas las aproximaciones en torno a la calidad de la asistencia por razones muy dispares como el tiempo de espera no debe ser prolongado, se debe ofrecer orientación a la familia y al usuario y garantizar un tratamiento óptimo y efectivo.

Todo esto permite comprender la necesidad de contar con sistemas de salud que respondan de forma acertada y coherente con las necesidades de las personas, como parte de los objetivos en salud a nivel mundial.

En este contexto, los centros de salud mental cumplen un papel muy importante para lograr la recuperación de las personas que enfrentan o sufren este tipo de problemas. No obstante, es necesario mencionar que no solo se trata de la intervención de un profesional en salud mental, sino que la atención que debe recibir una persona que acude a un centro de salud mental para ser atendido y contribuir a su recuperación, Con estas premisas, en este trabajo se analiza la importancia de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario que presenta problemas de salud mental.

1.2. Formulación del Problema:

Los centros de salud mental comunitaria están para responder a las necesidades de atención de los pacientes que sufren enfermedades mentales, según el Ministerio de Salud (MINSA), 2 de cada 10 peruanos (20%) padecen de algún trastorno mental; de 6,5 millones con problemas de salud mental, aproximadamente 5,2 millones no reciben atención. El porcentaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales en Perú, detectados en los servicios de salud mental, han pasado de 16.1% (2016), 25.48% (2018) y 24.92% (2021). (Tafur, S. 2023).

La satisfacción de la atención es un aspecto fundamental en la atención en salud, ya que está relacionada con la calidad del servicio que se brinda, lo cual podría entenderse como la conformidad expresada por el usuario en relación con sus expectativas sobre la atención recibida en todas las áreas que conforman las dimensiones de calidad. Es por ello la necesidad de plantear las siguientes preguntas de investigación:

1.2.1. Problema General:

¿Cuál es la relación entre la Calidad de la Atención y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?

1.2.2. Problemas Específicos:

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Elementos Tangibles y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Fiabilidad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Seguridad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?
- ¿Cuáles son los factores sociodemográficos de los usuarios del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?

1.3. Justificación de la Investigación:

Esta investigación se justifica desde la perspectiva teórica, ya que contribuirá a obtener información sobre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario ya que existe escaso número de estudios sobre la satisfacción del usuario que acude a un establecimiento de salud mental en esta comunidad, tema que se ha convertido en una pieza clave dentro de la práctica clínica. Esta intervención debe partir del reconocimiento del problema existente en el país para que la dotación de los servicios públicos sea adecuada para la atención y en el enfoque de salud mental comunitaria se privilegie una atención integral del usuario; por lo que la presente investigación será realizada para poder conocer la realidad de la atención en un centro de salud mental comunitario quienes acogen usuarios con trastornos mentales o problemas psicosociales, trastornos de depresión, ansiedad, esquizofrenia, problemas de conducta adictiva, y de violencia, donde la calidad en la atención podría hacer la diferencia en su mejoría, adherencia a un tratamiento y recuperación de los usuarios lo que nos permitirá encontrar respuestas de cómo están afrontando los centros de salud mental comunitario en la atención de este grupo vulnerable. Desde lo práctico, permitirá al Centro de Salud Mental Comunitario establecer medidas de mejora para poder brindar una atención integral al usuario y a sus familias de acuerdo con sus realidades necesidades.

1.4. Objetivos de la Investigación:

1.4.1. Objetivo General:

- Determinar la relación entre la Calidad de la Atención y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Identificar la relación entre la dimensión de Elementos Tangibles y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025
- Determinar la relación entre la dimensión de Fiabilidad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Establecer la relación entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Determinar la relación entre la dimensión de Seguridad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Identificar la relación entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Determinar los factores sociodemográficos de los usuarios del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Problema:

2.1.1. Internacionales:

Cayuela, et al. (2018), estos autores buscaron describir la relación entre la calidad asistencial percibida y la satisfacción frente a los servicios de Atención Primaria del Área de Salud II, en Colombia. La metodología usada fue diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional, tipo transversal. La muestra de estudio estuvo constituida por 24 personas sordas entre los resultados se encontró que el 66,7% calificó la calidad de la atención como "buena", mientras que el 29,1% la definió como "regular". En relación con la profesionalidad percibida del personal, la mayoría la calificó como "promedio". Se calificó la profesionalidad de los médicos como "regular" con un 54,2%, y con 52,2% para el personal administrativo, mientras que el personal de enfermería fue percibida como buena con 48,5% o muy buena 8,3%. Con relación al trato humano percibido, el 50% calificó el trato recibido por los médicos como "regular", el 45,8% calificó el trato recibido por las enfermeras como "bueno" y el 50% calificó el trato recibido por el personal administrativo como "regular". Los participantes se mostraron satisfechos, con 6,95 puntos. (Cayuela Fuentes et al., 2019)

Vélez, S. & González, Y. (2021), realizaron la investigación que tiene como objetivo Caracterizar los principales contenidos investigados y relacionados con la calidad de la atención de los servicios de salud en Colombia y publicados en el periodo 2010 - 2020. Se realizó una búsqueda bibliográfica de estudios publicados en los últimos 10 años en Colombia sobre la calidad de la atención en salud. Se hallaron 35 artículos con la implementación de diferentes descriptores: el 54,2% de los temas de los artículos revisados correspondían a calidad de la atención en salud, el 17,1% a calidad percibida en salud, el 11,4% a satisfacción del paciente, el 8,6% a calidad en salud, el 5,7% a gestión de la calidad y el 2,9% a tiempo de espera en la atención. Se encontró que el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) en Colombia presenta falencias que generan la no calidad de los servicios

en salud, por lo que se observa afectación de los diferentes principios como son la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la continuidad y pertenencia. Estos presentan barreras de tipo personales, económicas, geográficas, administrativas y políticas. Las barreras administrativas han sido un factor común en todos los principios de la calidad según los estudios revisados del SOGC, identificándose como la categoría de mayor relevancia que afecta la calidad de los servicios en salud, desde el ingreso a la institución, el proceso de atención y el resultado. Las investigaciones reportan que el atributo de acceso a la salud, fue el más vulnerado en el sistema de salud, La satisfacción del usuario se convirtió en un indicador esencial de la atención en salud, no solo permite evaluar su percepción, sino que es un indicador para el mejoramiento de la calidad e insumo para los sistemas administrativos y gerenciales de las instituciones. Los estudios revisados reportan que existe una tendencia a la insatisfacción donde no se da cumplimiento a las expectativas de los usuarios. Los estudios evidencian que los usuarios recurren a mecanismos como la queja y la tutela, ya que, a pesar de la normatividad en salud establecida. Los estudios reportan que el talento humano es considerado un pilar fundamental al momento de asegurar servicios de salud con calidad. Del conocimiento y la formación de los profesionales depende las intervenciones en la salud de las personas que lo requieren, estos deben estar en constante formación. En conclusión, se encontró que el SOGCS en Colombia presenta falencias que generan la no calidad de los servicios en salud, frente a la vulneración de derechos e insatisfacción de los servicios, los usuarios recurren a mecanismos como la queja y la tutela.

2.1.2. Nacionales:

Davila, B. (2023), realizó la investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre calidad de atención y satisfacción de los usuarios que acuden al Centro de Salud Mental Comunitario de Bellavista-Región San Martín con una población de 384 usuarios y con una muestra 134 usuarios. El método de investigación fue de enfoque

cuantitativo, descriptivo, correlacional y diseño no experimental. y se empleó el Cuestionario de calidad de atención percibido por los usuarios y el Cuestionario de Satisfacción del usuario de consultas externas. En los resultados se encontraron que la calidad de atención percibida por los usuarios es regular con un 55% de los encuestados, un 30% una pobre atención en cuanto a la calidad de atención recibida. En cuanto a calidad de atención un 52.2% expresó que fue regular, un 20.9% dijo ser baja y un 14.2% muy baja. Respecto a la capacidad de respuesta, el tiempo de espera altos tanto en atención como para la entrega de medicamentos fue regular dado por 50%. La seguridad en cuanto a un examen minucioso y que el profesional de salud sea apto para despejar sus dudas, fue calificada como regular en un 50%. La empatía fue considerada por un 53% como regular, la amabilidad, paciencia fue valorada de modo regular. Los elementos tangibles fueron considerados regulares en 54.5% en cuanto a su limpieza, comodidad y a disponer de los equipos necesarios para su atención. Un porcentaje elevado se encuentra satisfecho con un 46.3%, y más del 50% lo calificó como insatisfecho. En cuanto a la atención administrativa los usuarios se manifestaron medianamente satisfechos, siendo el 44.8%, en cuanto a la atención clínica sí mostraron su insatisfacción en un 70.1%, los tiempos cortos en la atención, la poca comprensión de los tratamientos y el trato del personal no lo consideran suficiente. La empatía como dimensión de la calidad de atención está correlacionada de manera positiva con la satisfacción del usuario. Los elementos tangibles como dimensión de la calidad de atención están correlacionados de manera positiva con la satisfacción del usuario. Se concluye que existe correlación significativa entre calidad de atención y satisfacción del usuario. (Davila Cossio, 2023)

Paredes, C. (2020), realizó la investigación Calidad de Atención y Satisfacción del Usuario Externo del Centro de Salud de zona rural peruana, estudio no experimental descriptivo, transversal, y correlacional, con una población de usuarios, mayores de edad, siendo 240 usuarios atendidos, de los cuales se obtuvo una muestra de 148. Los resultados fueron en la dimensión fiabilidad 7,4% de los usuarios

indican que la calidad está en proceso; el 58,1% indican que la calidad está por mejorar y el 34,5% indican que la calidad es aceptable. En la dimensión capacidad de respuesta se obtuvo el 13,5% de los usuarios indican que la calidad está en proceso; el 45,9% indican que la calidad está por mejorar y el 40,5% de los usuarios indican que la calidad es aceptable. En la dimensión seguridad el 7,4% de los usuarios indican que la calidad está en proceso; 48,0% indican que la calidad está por mejorar y 44,6% de los usuarios indican que la calidad es aceptable. En la dimensión empatía se tiene que 7,4% de los usuarios indican que la calidad está en proceso; 59,5% indican que la calidad está por mejorar y 33,1% de los usuarios indican que la calidad es aceptable. En la dimensión aspectos tangibles se tiene que 25,0% de los usuarios indican que la calidad está en proceso; 40,5% de los usuarios indican que la calidad está por mejorar y 34,5% de los usuarios indican que la calidad es aceptable. En la dimensión expectativa se tiene que 25,7% de los usuarios están insatisfechos con la atención, mientras que 74,3% de los usuarios están satisfechos con la atención. En la dimensión fidelización se tiene que 31,1% de los usuarios están insatisfechos con la atención, mientras que 68,9% de los usuarios están satisfechos con la atención. En la dimensión credibilidad se tiene que 31,1% de los usuarios están insatisfechos con la atención, mientras que 68,9% de los usuarios están satisfechos con la atención. En conclusión, las dimensiones de fiabilidad, empatía, capacidad de respuesta y fidelización están correlacionadas significativamente con la satisfacción del usuario externo. Por lo tanto, existe una relación positiva entre las variables calidad de atención y satisfacción del usuario.

Mundaca, N. (2019), realizó la investigación la cual tuvo como objetivo determinar la calidad de atención y la satisfacción percibida por el usuario externo del servicio de hospitalización del Hospital José Soto Cadenillas. Chota, 2018. La investigación tuvo como diseño no experimental, de tipo descriptivo, corte transversal. Se aplicó la encuesta a 40 usuarios de medicina y 55 de cirugía. El instrumento que se utilizó es la encuesta SERVQUAL modificada, para evaluar la satisfacción del usuario externo en el servicio de hospitalización (cirugía y medicina), se

usó la escala de SERVQUAL, obteniendo como resultado un 87,9% de los usuarios refieren que la calidad de atención en los servicios de medicina y cirugía es muy buena, el 12,1% señala que la calidad es buena. En la dimensión empatía el 87,9% de los usuarios indicaron que la calidad de atención fue muy buena; seguida de la dimensión seguridad con 82,8%, dimensión capacidad de respuesta alcanzó 77,8%, la dimensión de aspectos tangibles con 57,6% y por último la dimensión de fiabilidad con 53,5%. En la calidad de atención percibida como buena, la dimensión fiabilidad se presentó con 46,5% y aspectos tangibles con 33,3%. La calidad de atención percibida por los usuarios como buena ésta alcanzó el 12,12%, Sobre la calidad de atención percibida como muy buena se presentó en el 87,88% de los usuarios. En la dimensión de fiabilidad se presentó con 1,6%, y la insatisfacción con 51,3%, se encontró que en la dimensión de fiabilidad el 63,9% de usuarios se sintieron insatisfechos. La satisfacción en la dimensión de seguridad se ha presentado en 1,0% y la insatisfacción de los usuarios es de 57,1%. En la dimensión de empatía, la satisfacción de los usuarios se presentó en 0,4% y la insatisfacción con 31,3%. Los hallazgos del estudio muestran un índice global en esta dimensión de 61,4%, es decir, los usuarios están insatisfechos y perciben que la atención debe mejorar, se ha encontrado insatisfacción con un valor de 80,8%, en la limpieza de los ambientes, Los usuarios perciben que la calidad de atención de salud como muy buena y buena. La calidad de atención muy buena predominó en las dimensiones: empatía, seguridad, capacidad de respuesta, aspectos tangibles y en la dimensión de fiabilidad. En cuanto a la satisfacción según dimensiones: en fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles la satisfacción de los usuarios alcanzó 2%, sin embargo, la insatisfacción presentó proporciones elevadas. (Mundaca Constantino, 2019)

Repetto, L. (2022), realizó la investigación cuyo objetivo era determinar la calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Mental Comunitario de La Perla, 2021. El diseño del estudio fue descriptivo-correlacional, de tipo no experimental, de corte transversal. La investigación estuvo determinada por 76 usuarios

externos del Centro de salud mental comunitario La Perla, quienes asistieron en el mes de septiembre del 2021. El instrumento administrado fue el Servperf, entre los resultados que se encontraron de las personas encuestadas se encontró un 68.4% de sexo femenino. En cuanto al rango de edad son adultos con un 81.6%, de 30 a 59 años además un 47.4% manifestaron tener estudios técnicos concluidos. En relación con la calidad de servicio que existe una mayoría de los encuestados que percibió un nivel alto (63.2%) representado por 48 personas además otro porcentaje de usuarios perciben un nivel regular (27.6%) representado por 21 personas, en comparación de un porcentaje mínimo que percibe una calidad baja (9.2%) representado por 7 personas. La percepción del usuario en cuanto a la dimensión de fiabilidad se encontró un 48.7%, es decir que de los 76 usuarios encuestados 37 de ellos consideran un nivel alto en la atención recibida, sin embargo, hay un porcentaje con un 35.5% representado por 27 personas que percibieron lo contrario con un nivel regular y 15.8% representado por 12 personas percibieron insatisfacción en cuanto a la calidad de servicio que brinda el establecimiento. El 61.8%, representado por 47 de los usuarios encuestados percibieron un nivel alto de satisfacción respecto a la calidad de respuesta que muestra el personal de salud del Centro de Salud Mental Comunitario de La Perla, es decir percibieron que la atención en farmacia y admisión es rápida y se muestran conformes con el tiempo de espera en comparación de un 32.9% representado por 25 personas que percibieron un nivel medio de satisfacción y un 5.3% representado por 4 personas percibieron un nivel bajo de respecto a esta dimensión. Un 81.5% representado por 62 personas consideró un nivel alto respecto a la dimensión de seguridad, un 17.1% representado por 13 personas manifestó un nivel medio y un 1.3% percibió un nivel bajo de satisfacción. El 89.5% de la población encuestada representada por 68 personas percibió un nivel alto respecto a la empatía que presenta el personal de salud del establecimiento, un 9.2% representado por 7 personas manifestaron un nivel medio en cuanto a su percepción y un porcentaje de la muestra encuestada manifestó un nivel bajo con un 1.3%. Un 68.4% representado por 52 personas obtuvo una percepción alta y existe un porcentaje igual de usuarios 15,8% que percibieron entre

medio y bajo la dimensión de elementos tangibles. El 47.3% representado por 36 personas declararon estar satisfechos con la calidad de servicio brindada por el establecimiento. Un 36.8% representado por 28 personas declararon estar regularmente satisfechos, y un 15.8% representado por 12 personas declararon estar insatisfechos en cuanto a la calidad de los servicios. El 64.4% representado por 49 personas manifestaron sentirse satisfechos con el trato que brinda el establecimiento, sin embargo, existe un porcentaje que manifestó estar regularmente satisfecho, con un 21% representado por 16 personas y un 14.4% representado por 11 personas consideraron sentirse insatisfechos. El 46.05% (35 usuarios externos) manifestó estar satisfecho con la dimensión Técnico-Científica que presenta el personal de salud del establecimiento, sin embargo, existe un porcentaje relativamente. El 84.2% (64 personas) manifestaron estar satisfechos con la dimensión entorno, mientras que el 13.1% manifestó estar regularmente satisfecho y un 2.6% de la muestra encuestada manifestaron sentirse no satisfechos. Se concluye que existe una relación positiva, moderada y significativa entre la calidad de servicio y satisfacción del usuario en el centro de salud mental comunitario La Perla, 2021. (Repetto Tkachenko, 2022)

Monroy, K. (2023), realizó una investigación titulada Calidad de Atención a Usuarios Externos en Centro de Salud Mental Comunitario, de tipo cuantitativo y de diseño observacional, transversal, prospectivo. Con una muestra de 335. Según la tabla 1, el 68.4% son usuarios del sexo femenino los que acuden al establecimiento, mientras que el 31.6% fueron usuarios masculinos. El 71% de usuarios que acuden por consulta externa fueron los usuarios propiamente dichos, mientras que un 29% fueron los acompañantes porque acudían a alguna especialidad de rehabilitación. El 73.7% son usuarios continuadores que acuden a sus atenciones por especialidad, mientras que un 26% fueron usuarios nuevos que acudieron al Centro de Salud Mental Valle Pocollay. El centro de salud mental brinda una calidad de atención calificada según las percepciones de los usuarios como Buena con un 71.9%, pero para otro grupo con un 25,1% lo calificó como regular la atención, mientras

que un 3% calificó como muy buena. El 61.8% califica como mala la estructura del centro de salud mental valle Pocollay, mientras que solo el 3% lo califica como bueno. El 68% califica como muy buena el componente proceso de la calidad de atención mientras que un 4.8% como excelente y el 27.2% como buena. El 63.9% calificó como muy buena la atención en el centro de salud mental comunitario Valle Pocollay, un 26,6% como buena el componente resultado de la calidad de atención. (Monroy Huanca, 2023)

Medina, E. (2022), descriptivo correlacional, de diseño no experimental, En el estudio la población la conformaron 870 usuarios que son el promedio de usuarios que fueron atendidos en los 3 primeros meses del año 2021, Según al nivel de calidad de atención, se evidencia que un 77,9 % de usuarios considera que el nivel de calidad de atención es bueno, cabe mencionar que un 19,5 % lo considera regular y solo un 2,6 % lo considera malo, Según al nivel de satisfacción, se evidencia que un 69,3 % de pacientes se encuentran muy satisfechos dicho porcentaje evidencia que más de la mitad de los usuarios evalúan favorablemente tanto la atención administrativa que incluye el tiempo de espera para la consulta y también los trámites que tuvieron que realizar para ser atendidos; un 26,6 % refieren estar medianamente satisfechos y solo un 4,1 % indica estar insatisfecho siendo este último resultado indicador de que hay aspectos que mejorar tanto en la parte administrativa como en el aspecto de la atención clínica. El nivel de calidad de las cinco dimensiones tiene una valoración casi similar, siendo las dimensiones de empatía y seguridad que fueron calificadas con un nivel de calidad bueno obteniendo un mayor porcentaje de 86,9 % y 82,4 % respectivamente, un porcentaje elevado de 43,1% de los usuarios considera un nivel de calidad regular con respecto a los aspectos tangibles lo que sería justificado ya que a veces no encuentran un área cómodo donde esperar su consulta, un porcentaje menor de 2,2 % considera con un nivel malo a la dimensión de la empatía, se concluye que Existe relación significativa directa alta, entre la calidad de atención en salud y la satisfacción del usuario en el Centro Médico EsSalud Calca, Cusco, 2021. (Medina Gonzales, 2022)

Richard J. Febres-Ramos & Miguel R. Mercado-Rey (2020)

realizaron una investigación para conocer la calidad de atención brindada por los servicios de salud medida a través del nivel de satisfacción de los usuarios consistió en un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, realizado en los consultorios externos de medicina interna del hospital Daniel Alcides Carrión del departamento de Huancayo, durante el período de julio a noviembre del 2016. La población estudiada estuvo conformada por 10 726 pacientes que se atendieron por la consulta externa constituida por 292 pacientes. Para medir la calidad de servicio que ofrece el sistema de salud se utilizó el cuestionario estandarizado SERVQUAL. El 61,0% del total de la muestra fue de sexo femenino, las edades más frecuentes oscilaron entre 36 a 45 años. El 34,0% de los pacientes contaban con secundaria completa, el 66,0% tenía Seguro Integral de Salud (SIS) y el 67% fueron pacientes continuadores. El nivel de satisfacción del total de la muestra evaluada fue del 60,3%, y el 39,4% de los pacientes atendidos, estuvo insatisfecho con la atención recibida. Concerniente a la calidad de la atención, el 86,8% y el 80,3% de los usuarios evidenciaron estar satisfechos con la seguridad y la empatía brindada durante el momento de la atención, respectivamente. El presente estudio evidenció que, de los 292 usuarios el 60% aproximadamente estuvo satisfecho con la calidad del servicio recibido, se sintieron más satisfechos con la seguridad y empatía percibida en el servicio recibido. El nivel de satisfacción de la calidad del servicio de los usuarios en el consultorio externo fue 60,3%; las dimensiones seguridad y empatía fueron la que tuvieron el mayor nivel de satisfacción percibido por los usuarios, mientras que la dimensión de aspectos tangibles fue la que obtuvo el mayor porcentaje de insatisfacción.

2.2. Bases Teóricas:

2.2.1. Calidad de la atención:

Es un conjunto de atributos con peculiaridad que responden a las necesidades de una persona, disminuyendo los riesgos y evitando efectos iatrogénicos. (Paredes Larios, 2019)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la calidad de los servicios de salud en la manera como satisfacer las necesidades de salud de las personas, las familias y las comunidades con base en las mejores prácticas, la ética y el conocimiento científico, contribuyendo a la equidad y al bienestar, sin dejar a nadie atrás, con niveles óptimos de seguridad, efectividad, oportunidad, eficiencia y acceso equitativo como atributos esenciales de su definición. (Vélez, S. & González, Y., 2021).

Según Donabedian la Calidad de Atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio favorable de riesgos y beneficios para el usuario. (Mundaca Constantino, 2019)

Dimensiones de la Calidad en salud:

Existen diversas propuestas, pero la presentada por Donabedian siga siendo, la de mayor aceptación cuando propone tres dimensiones:

a. Dimensión Técnico-Científica, referida a los aspecto científico-técnicos de la atención, cuyas características básicas son:

- Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud de la población.
- Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud a través de la aplicación de las normas técnicas y administrativas.

- Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados esperados.
- Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o repeticiones innecesarias.
- Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud está determinada por la estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario.
- Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante.

b. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez tiene las siguientes características.

- Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la persona.
- Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quien es responsable de él o ella. Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y demandas; lo que es asimismo válido para el usuario interno.
- Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención.
- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios éticos deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y trabajadores de la salud.

c. Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles.

- Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio. La Gestión de la Calidad es el

componente de la gestión institucional que determina y aplica la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades en el marco del sistema de gestión de la calidad y se llevan a cabo mediante planificación, garantía y mejoramiento de la calidad. (Mundaca Constantino, 2019)

En el caso de la atención de salud, la calidad no puede referirse solamente a la "Satisfacción del paciente", pues el usuario pudo haber salido de la consulta satisfecho de la atención recibida, sin embargo su problema de salud no fue resuelto.

Donabedian, enfatiza el análisis de la calidad a partir de tres enfoques. (Mundaca Constantino, 2019)

Estructura: Disponibilidad de tiempo del personal de salud para los usuarios, incorporación de comodidades al ambiente físico e instalaciones, disposición y funcionamiento de mecanismos de sugerencias o quejas de los usuarios, participación de la población.

Proceso: es la manera como el personal de salud atiende a los usuarios, el interés, la cortesía, el respeto, la privacidad, la información o explicación del problema, la confianza, el apoyo, la aceptación del paciente sin hacer juicios sobre su enfermedad y su conducta, y el tiempo necesario requerido por el paciente.

Resultado: Es la satisfacción del paciente con la atención recibida, comprensión de la enfermedad y del régimen de atención, hacer frente con éxito a la enfermedad, conocimiento de los intereses y problemas del paciente. (Mundaca Constantino, 2019)

Calidad en la salud mental:

Se han propuesto diversas definiciones específicas de calidad en la atención psiquiátrica. Es así que la calidad de la salud mental se define como el grado en que los servicios de salud satisfacen las necesidades, las expectativas y los estándares de atención de la persona, sus familias y otros beneficiarios de la atención. Los factores fundamentales en

cuanto a la calidad de la atención son la visión de la persona sobre la atención prestada, el resultado del tratamiento, la actitud del personal, el ambiente o infraestructura y el servicio de salud mental. Las acciones de calidad en el ámbito de la salud mental están orientadas a la mejora de la efectividad, de la práctica asistencial, incorporar la experiencia de los pacientes con los tratamientos, minimizar el riesgo, en la asistencia, y mejorar la cultura de la calidad y seguridad de los pacientes y profesionales. Las estrategias de calidad centradas en el ámbito de la salud mental se centran en priorizar la prevención, uso seguro de medicamentos, manejo de conductas agresivas, prevención y manejo de conductas restrictivas.(Balcells et al., 2020)

Normativa técnica de los centros comunitarios en Perú Según la norma técnica N.º138-MINSA-2017, los Centros Comunitarios de Salud Mental una buena calidad de atención cuenta con las siguientes características: Realizar asistencia técnica, capacitación y seguimiento a los establecimientos del primer nivel de atención que se encuentran en su jurisdicción. Brindando atención ambulatoria especializada a pacientes con trastornos mentales y/o problemas psicosociales. Brindar paquetes de atención por usuario para lograr la rehabilitación total asociada a los servicios del nivel de atención. Promocionar a la salud mental con tratamiento y rehabilitación a la comunidad actividades.

Dentro de la norma técnica se especifica su infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud con categoría de 1er nivel de atención, la infraestructura de los centros de salud mental tiene ciertas especificaciones que genera confianza y secuencia de tratamientos, espacios detallados y equipos según su norma técnica adaptables al medio ambiente, cuanta con las siguientes unidades:

a. Ambientes de prestaciones clínicas – psicosociales este grupo comprende Sala de acogida y valoración inicial: donde el profesional realizara valoración clínica y controles vitales. Consultorios individuales: que deben estar señalizados y orientados hacia la atención de niños y adolescentes y otros asignados a la atención de adultos, adultos mayores y adiciones. Tópico de procedimientos y toma de muestra: destinado al profesional encargado de tópico. Reposo: destinado al

paciente con crisis y que requiera observación. Farmacia: ambientes de recepción, conservación y dispensación de medicamentos. Sala de trabajo de grupo: para intervenciones del área de participación interdisciplinaria. Módulo de terapia de lenguaje: destinado al tecnólogo médico terapeuta de lenguaje. Sala de talleres de rehabilitación psicosocial para niña(os): son ambientes diseñados a la rehabilitación física, psicosociales, ocupacional y juego para niños. Servicios higiénicos para los usuarios: considerado de acuerdo a la normativa con servicios diferenciados, y tener un servicio para las personas con discapacidad.

b. Ambientes prestaciones socio comunitarias y de capacitación Salas zoom multiusos: adecuado hacia los actores sociales y reuniones mensuales elaboración de informes entre otros para uso del profesional de la red. Cocina, comedor: espacio equipado con electrodomésticos para los usuarios.

c. Ambientes complementarios de admisión: Informes: área destinada para orientar sobre la cartera de servicios de salud mental que provee el centro comunitario. Admisión citas y caja: es el área donde gestiona el ingreso de los usuarios al establecimiento y se orienta sobre el flujo de atención. Archivo de historias clínicas: espacio destinado al guardado de historias clínicas de los usuarios. Sala de espera: destinado al espacio para las personas o familiares mientras esperan ser atendidos. Servicios higiénicos personal varones/ mujeres más vestuario: debe ser de acuerdo a las características que establece la norma técnica para infraestructura.

d. Ambientes complementarios de apoyo servicio de limpieza y mantenimiento: diseñado hacia el patio o jardín. Almacén: espacio amplio para almacén general. Así también detallan en el área de recurso humano, los centros comunitarios cuentan con un médico psiquiatra, con un médico de familia, con tres a más psicólogos, con cuatro a más enfermeros, con una trabajadora social, con un Tecnólogo Méd. para terapia de lenguaje y para terapia ocupacional, con dos técnicos de enfermería, con un personal administrativo, con un personal estadístico,

con un químico farmacéutico, con un técnico y dos personales de limpieza (Monroy Huanca, 2023)

2.2.2. Satisfacción del usuario:

La satisfacción es una respuesta cognoscitiva del usuario, respecto a la atención médica, conjunto de aspectos eminentes, vinculados a la calidad de atención, convirtiéndose en pieza clave para obtener información relevante. En salud pública es un indicador fiable que la calidad de la atención. La valoración desde la perspectiva ha denotado múltiple esfuerzo, generando un análisis y proponiendo nuevas iniciativas de mejora, de igual manera.

La Satisfacción del Usuario Externo es el juicio de valor emitido de acuerdo con la percepción del individuo en relación con las condiciones de las áreas físicas y características del servicio recibido. Precisan que la satisfacción del usuario se refiere al conjunto de actitudes y comportamientos hacia un objetivo particular (calidad de la atención médica recibida). Una revisión panorámica de los estudios realizados nos permite afirmar que la satisfacción del usuario, con los servicios de salud, depende en gran medida de la calidad de los servicios que ofrecen y el trato personal que reciben del médico. (Mundaca Constantino, 2019)

La satisfacción de los usuarios está constituida por tres elementos el primero es el rendimiento percibido, se define como el resultado que el usuario percibe después de adquirir o recibir un servicio; esta apreciación tiene factores influyentes tales como estado de ánimo del usuario y el uso de la razón, está justificado en la impresión del usuario, es sustancial. Seguidamente de las expectativas es la probabilidad o “esperanza” que el usuario tiene por obtener algo. La perspectiva del usuario permite crear diversas sensaciones tales como compromisos que realiza las entidades de salud, asimismo la experiencia basada en atenciones anteriores y la influencia de la recepción de información externa contribuye a formar una percepción concreta de los sistemas de salud. (Paredes Larios, 2019)

El papel que juega la opinión de los usuarios, sus percepciones y los juicios que realizan sobre los servicios recibidos son aspectos claves en la definición de la calidad y su valoración es imprescindible para prestar una correcta asistencia sanitaria. La percepción del paciente es, por tanto, una de las medidas principales a la hora de evaluar y mejorar la calidad de la asistencia.

Es importante la actitud de los profesionales de la salud frente al cliente, esta experiencia puede significar una actitud en contra o a favor del sistema de salud, así como el tiempo de espera en la consulta, en definitiva es crucial para satisfacer al usuario, influyendo en su estado de ánimo y comportamiento, generando un ambiente de tensión con el personal de salud.

Para mejorar la satisfacción de los usuarios hacen falta actuaciones decididas de distinta naturaleza (organización, formación, información y recursos). Las razones para medir la satisfacción pueden resumirse en cuatro:

- Obtener una retroalimentación imprescindible para la gestión y optimización de los recursos sanitarios,
- Porque constituyen una medida legítima de la capacidad de la organización para dar cuenta de las necesidades de los usuarios, pudiendo ser utilizado como un indicador en el control de calidad del servicio,
- La satisfacción es uno de los activos con los que cuentan las organizaciones para lograr mejoras competitivas y resultados estables a medio plazo,
- Es un predictor de las reacciones o comportamiento de los usuarios: lealtad, prescripción, adherencia al tratamiento, etc.

Las quejas más frecuentes entre los pacientes son: Comunicación médico-paciente Inadecuada información o ausencia de esta, Informaciones incongruentes por parte de varios profesionales, no respetar la confidencialidad o intimidad del paciente. Relación médico-paciente Falta de cortesía o trato rudo y percepción de maltrato por parte

del paciente. Accesibilidad y disponibilidad Las dificultades de accesibilidad al médico, demoras o dificultades para obtener cita, cambios injustificados de cita y no atender las llamadas del paciente. (Mundaca Constantino, 2019)

Las expectativas que los pacientes tienen con respecto a la atención también influyen en la satisfacción, la cual es menor cuando las expectativas son mayores, describe tres elementos que distinguen una relación satisfactoria con el médico desde la perspectiva de los pacientes. Estos elementos son: sentirse tratado y reconocido como persona, recibir información sobre la enfermedad y el cuidado, y percibir interés por su recuperación de parte del médico. La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante en su comportamiento. (Mundaca Constantino, 2019)

2.2.3. Trastorno de salud mental:

La prevalencia de trastornos mentales que guarda relación con la psicosis, esquizofrenia relacionada al abuso y dependencia del alcohol, así como los trastornos de depresión y de ansiedad se han duplicado desde tiempos de pandemia, siendo una muestra más de la importancia de dar prioridad a la salud mental. Las personas experimentan sufrimiento psicológico que perturban su salud mental; además la estigmatización, discriminación y prejuicios sociales a las personas con enfermedades mentales marcan negativamente y perjudican su recuperación, su integración en la sociedad y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Todo esto genera que, a pesar de la disponibilidad de tratamientos basados en la evidencia muy efectivos, gran parte de las personas con enfermedades mentales no reciban atención y muchos de los que comienzan una intervención no logren completarla. (Lozano & Pizarro, 2024)

2.3. Marco conceptuales o glosario:

Calidad: Totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio, que se refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresas implícitas.

Calidad de atención: Es el conjunto de actividades que realizan los establecimientos de salud con servicios médicos en el proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar efectos deseados por los proveedores y también de los usuarios, de la seguridad, eficacia y satisfacción del usuario

Calidad de la atención en salud: consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica y la relación interpersonal, que es la interacción social, cultural y económica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. (Mundaca Constantino, 2019)

Atención al usuario: Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas.

Primer nivel de atención: Es donde se desarrollan actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje de intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona, familia y comunidad. (Monroy Huanca, 2023)

Establecimiento de salud: Son aquellos que realizan en régimen ambulatorio o de internamiento, atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para mantener o restablecer el estado de salud de las personas

Estructura: Es el entorno en el que se brinda la atención de salud e incluye recursos materiales y de salud, factores operativos y características organizativas del establecimiento de atención de salud.

Proceso: Es el método mediante el cual se brinda atención médica e incluye la prestación y recepción de atención por parte de los proveedores y el sistema de atención médica

Resultado. Es consecuencia de la atención sanitaria e incluye el estado de salud de los pacientes.

Salud mental: Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad.

Satisfacción del usuario externo: Es el grado del cumplimiento de parte de la organización de la salud con respecto a las expectativas y percepciones del usuario según los servicios que recibe

Dimensión aspectos tangibles Abarca la apariencia de las instalaciones físicas, tanto equipos como materiales de comunicación y al personal.

Dimensión fiabilidad Describe la destreza que se tiene para realizar el servicio ofrecido, siendo fiables y muy cuidadosos.

Dimensión capacidad de respuesta Es la predisposición de los proveedores para ayudar a los usuarios y dotarlos del servicio requerido de manera rápida y eficaz

Dimensión seguridad engloba la totalidad de conocimientos, habilidades como también la atención que muestran los colaboradores para infundir confianza y credibilidad.

Dimensión empatía Viene a ser toda la atención personalizada que otorgan las empresas a sus consumidores. (Medina Gonzales, 2022)

III. HIPOTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis General

- Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la Calidad de la atención y Satisfacción del usuario del Centro de Salud Mental Comunitario Villa Campoy, 2025.

3.1.2. Hipótesis Específicas:

- Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Elementos Tangibles y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025
- Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Fiabilidad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Seguridad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.
- Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.

3.2. Identificación de Variables

Variable Independiente

- Calidad de la atención

Variable Dependiente

- Satisfacción del Usuario

Variables sociodemográficas

- Edad
- Sexo
- Nivel socioeconómico
- Grado de instrucción

3.3. Operacionalización de Variables:

°	Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Escala De Medición	Tipo De Variable Relación Y Naturaleza	Categoría O Unidad
Variable Dependiente	Nivel de Satisfacción	El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas.	Es la opinión del usuario externo sobre la dimensión atención médica humana, atención administrativa del entorno de la calidad de atención de salud, será medida a través de un cuestionario de 12 ítems (6 para cada dimensión) de consulta externa	Ordinal	Cualitativa	1 = la menor calificación que se está totalmente insatisfecho 5 = como la mayor calificación totalmente satisfecho
Variable Independiente	Calidad de la atención	Es la diferencia entre las percepciones reales por parte de los usuarios del servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado previamente.	La calidad del servicio que brinda el personal será medida por las expectativas y percepciones que revelan a través del cuestionario del modelo SERVQUAL	Ordinal	Cualitativa	1 = la menor calificación que se está totalmente insatisfecho 5 = como la mayor calificación totalmente satisfecho

3.4. Matriz de Consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	VI: Calidad de la atención	Enfoque: Cuantitativo.
PG. ¿Cuál es la relación entre la Calidad de la atención y Satisfacción del Usuario del Centro de Salud Mental Comunitario Villa Campoy, 2025?	Determinar la relación entre la Calidad de la atención y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.	Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la Calidad de la atención y Satisfacción del usuario del Centro de Salud Mental Comunitario Villa Campoy, 2025.	- Elementos Tangibles - Fiabilidad - Capacidad de respuesta - Seguridad - Empatía	Diseño: No experimental. Nivel: Descriptivo - Correlacional. Tipo: transversal y analítico
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas	VD: Satisfacción del Usuario	Población y muestra:
PE1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Elementos Tangibles y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?	OE1. Identificar la relación entre la dimensión de Elementos Tangibles y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025	HE1. Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Elementos Tangibles y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.	- Atención clínica (7-14) - Atención Administrativa (1-6)	261 usuarios mayores de 18 años que tengan diagnóstico de ansiedad, depresión, esquizofrenia paranoide, problemas de conducta adictiva o situación de violencia.
PE2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Fiabilidad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?	OE2. Determinar la relación entre la dimensión de Fiabilidad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.	HE2. Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Fiabilidad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025		
PE3. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?	OE3. Establecer la relación entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025	HE3. Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025		
PE4. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Seguridad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?	OE4. Determinar la relación entre la dimensión de Seguridad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025.	Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Seguridad y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025		
PE5. ¿Cuál es la relación entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?	OE5. Identificar la relación entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025	Existe relación estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025		
¿Cuál es la relación entre la dimensión de Empatía y Satisfacción del Usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025?				

Variables sociodemográficas

- Edad.
- Sexo.
- Grado de instrucción.
- Nivel Socioeconómico
- Lugar de procedencia

Técnicas: Encuesta

Instrumentos:

Encuesta de SERVQUAL MODIFICADA

Estadística:

Descriptivo con cálculos de frecuencias, porcentajes y desviaciones, estadísticos de correlación Rho Spearman.

IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo y Diseño de investigación:

Esta investigación es del tipo cuantitativo y de diseño no experimental observacional, transversal. Según la intervención es de tipo observacional, porque se observará a los usuarios, para obtener los resultados sin que estos fueran influenciados por el investigador. Según el alcance, es de tipo descriptivo, porque se recolectarán datos sin cambio en el entorno es decir que no habrá intervención alguna. Según el número de mediciones es de corte transversal porque se tendrá que interpretar e identificar la calidad de atención y satisfacción del usuario en una población de estudio definida, que fueron los usuarios de consulta externa del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, con un punto específico de tiempo que será en el año 2025.

4.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis será usuarios adultos, del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, en condición de pacientes continuadores.

4.3. Criterios de inclusión y exclusión

4.3.1. Criterios de Inclusión

- Usuario cuya edad sea de 18 años a más, que tenga historia clínica en el centro de salud mental comunitario Villa Campoy
- Usuarios continuadores que al menos hayan tenido una consulta en psicología, psiquiatría y enfermería en el Centro de Salud Mental Comunitario.
- Usuarios que tengan como diagnóstico de atención Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia Paranoide, Adicción al tabaco o al alcohol o problemas de Violencia familiar

4.3.2. Criterios de exclusión

- Usuarios con problemas neurológicos
- Usuarios con diagnóstico de retardo mental severo, moderado o leve.

4.4. Población de Estudio:

La población de estudio es de 400 usuarios con historia clínica de adultos continuadores del centro de salud mental comunitario Villa Campoy que tengan como diagnóstico depresión, ansiedad, problemas de violencia o adicciones, esquizofrenia.

4.5. Tamaño de Muestra

El tamaño mínimo de la muestra se determinará utilizando la fórmula de cálculo de muestra simple, aceptando un error estándar hasta 5% (0.05) para establecimientos de salud de categoría I, y con un nivel de confianza del 95% asumiendo un $p=0.5$ y un $q=0.5$ y la población de estudio comprende a un total de $N: 400$. Por lo que el cálculo estimado de la muestra es de $n: 197$.

4.6. Selección de Muestra:

El tipo de muestra que se empleó para esta investigación fue no probabilístico intencional por conveniencia ya que se administrará la encuesta y los instrumentos al salir del consultorio de psiquiatría, según el flujo de atenciones que brinda dicho establecimiento a los usuarios que acudan en el año 2025.

4.7. Técnica de Recolección de Datos:

FICHA TÉCNICA DE CALIDAD DE ATENCIÓN:

1. Título: SERVQUAL modificado
2. Autora: Zeithaml, Parasuraman y Berry adaptado por el MINSA Año: 2018
3. Duración: 20 minutos
4. Aplicación: Pacientes que acuden al Centro de Salud Mental Comunitario
5. Significación: Manejo de Información de Contenido
6. Administración y Calificación: Se administró utilizando los siguientes materiales: • Hoja de Respuesta • Lápiz, evaluación es manual y la valoración osciló entre 110 (máximo) y 22 (mínimo).

7. Consigna Califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le otorga al servicio de Consulta Externa. Utilice una escala numérica del 1 al 5. Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación.

Tabla 1: GENERACIÓN DE BAREMOS SATISFACCION

<i>Escala de calificación</i>	<i>CATEGORÍAS</i>
>60%	<i>Por mejorar</i>
40 – 60 %	<i>En Proceso</i>
<40%	<i>Aceptable</i>

Tabla 2: ANÁLISIS DE FIABILIDAD

Estadísticos de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,88.9	385

Estructura: Contiene 22 ítems.

Las dimensiones: son 5; X1 fiabilidad X2 capacidad de respuesta X3 seguridad X4 empatía X5 elementos tangibles

Se encuesta personalmente o colectiva, durante 20 minutos.

Calificación y Puntuación: La evaluación es manual y la valoración osciló entre 110 (máximo) y 22 (mínimo).

FICHA TÉCNICA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

1.Título: Cuestionario de satisfacción del usuario de consultas externas (SUCE)

2.Autora: Susana Granado de la Orden, Cristina Rodríguez Rieiro, María del Carmen Olmedo Lucerón, Ana Chacón García, Dolores Vigil Escribano y Paz Rodríguez Pérez

3. Año: 2006

4.Duración: 20 minutos

5.Aplicación: Pacientes que acuden al Centro de Salud Mental Comunitario

6.Significación: Manejo de Información de Contenido

7.Administración y Calificación: Se encuesta de modo personal y grupal durante 20 minutos. 5 = Totalmente de acuerdo 4 = De acuerdo 3 = Indiferente 2 = En desacuerdo 1= Totalmente en desacuerdo

8.Consigna: Marcar del 1 al 5 las siguientes situaciones percibidas en este Establecimiento de salud. Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación. Este cuestionario nos ayudará a mejorar como institución las atenciones a nuestros usuarios. Agradecemos su participación.

Tabla 1: GENERACIÓN DE BAREMOS SATISFACCION

<i>Escala de calificación</i>	<i>CATEGORÍAS</i>
>60%	<i>Por mejorar</i>
40 – 60 %	<i>En Proceso</i>
<40%	<i>Aceptable</i>

Tabla 2: ANÁLISIS DE FIABILIDAD

Estadísticos de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	de N elementos	de
0,90	671	

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Variables	Alfa de Cronbach	N de elementos
Calidad de atención	,830	22
Satisfacción del usuario	,925	14

Al efectuar la prueba piloto con 30 encuestados se obtuvo que el coeficiente Alfa de Cronbach para ambas variables tuvo un valor superior a 0.7, por ello se determinó que era confiable para su aplicación a la muestra total.

4.8. Análisis e interpretación de la información

Los datos recogidos se registrarán en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2019, donde se incluirán algunos criterios de validación, esto con el propósito de poder evitar posibles errores de digitación u omisión de datos que puedan contribuir a obtener resultados no válidos. Estos datos posteriormente serán analizados mediante el paquete estadístico SPSS V.25.

El análisis univariado: Según el plan de análisis del estudio, consistirá en analizar de manera nominal cada variable estudiada así como sus respectivas dimensiones tanto en su frecuencia (f), porcentajes (%), y los resultados se presentarán en tablas.

Posterior a ello se realizará el análisis bivariado, para identificar los factores que estén relacionados a la Calidad de la atención y Satisfacción del usuario, para ello se empleará la prueba estadística *rho de Spearman (distribución no normal)*.

4.9 Consideraciones éticas

Se contactará con la oficina de docencia e investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro y se presentará una solicitud de permiso para ejecutar protocolo de investigación en usuarios del Centro de Salud Mental Comunitario Villa Campoy durante el periodo 2025. La información será revisada solo con fines de investigación, y tendrá carácter confidencial, no se revelará la identidad u otro tipo de información del personal.

V. PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO (S/)	
			UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS				
Asesor estadístico	Meses	2	S/. 900	S/. 1800
BIENES				
Papel bond A-4	Medio millar	3	s/. 10	s/. 30
Lapiceros	Unidad	4	s/. 2	s/. 8
Corrector	Unidad	1	s/ 3.50	s/ 3.50
Resaltador	Unidad	3	s/ 3.50	s/ 10.50
Perforador	Unidad	1	s/. 6	s/. 6
Engrapador	Unidad	1	s/.10	s/.10
Grapas	Caja	1	s/. 4	s/. 4
CD – USB	Unidad	1	s/. 50	s/. 50
Espiralado	Unidad	3	s/. 5	s/. 15
Internet	Horas	100	s/. 1	s/. 100
Fotocopias	Unidad	200	s/. 0.10	s/. 20
Movilidad	Pasaje	100	s/. 5.00	s/. 500
COSTO TOTAL				s/. 2,557

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[illegible]

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado, J; Contreras, L. & Cruz, C. (2021). Experiencias familiares, estrategias de afrontamiento y salud de madres y padres de niñez con autismo. *Estudios Centroamericanos*, vol 76, N 764.
- Antinori Jaén, K. I., Ilizarbe González, G. S., & Lino Suárez, A. M. (2022). *Análisis de la implementación y gestión del Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto del distrito de Villa María del Triunfo, sustentado en el “Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018—2021”*. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/22366>
- Balcells, S. S., Llobet, M. P., Canut, M. T. L., & Roldán, J. F. (s. f.). Evolución del concepto de calidad de los cuidados en salud mental. *SALUD MENTAL*.
- Cayuela Fuentes, P. S., Pastor Bravo, M. del M., Conesa Guillén, M. de los Á., Cayuela Fuentes, P. S., Pastor Bravo, M. del M., & Conesa Guillén, M. de los Á. (2019). Calidad asistencial percibida y satisfacción de las personas sordas con la atención primaria de un Área de Salud de la Región de Murcia. *Enfermería Global*, 18(54), 303-322. <https://doi.org/10.6018/eglobal.18.2.344761>
- Davila Cossio, B. V. (2023). Calidad de atención y satisfacción de los usuarios que acuden al Centro de Salud Mental Comunitario de Bellavista-Región San Martín. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/126674>
- Larios, C. del P. P. (2020). CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DEL CENTRO DE SALUD DE ZONA RURAL

PERUANA. *Revista Científica de Enfermería (Lima, En Línea)*, 9(1), Article 1. <https://revista.cep.org.pe/index.php/RECIEN/article/view/14>

Lozano, J. S., & Pizarro, S. M. (2024). Manejo del estigma en los enfermos mentales. *Revista Cubana de Salud Pública*, 50. <https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/16799>

Medina Gonzales, M. E. (2022). *Calidad de atención en salud y satisfacción del usuario en el Centro Médico Essalud Calca, Cusco, 2021.*

Monroy Huanca, K. E. (2023). Calidad de atención a usuarios externos centro de salud mental comunitario Valle Pocollay Tacna. *Repositorio Académico USMP*. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/renati/237477>

Mundaca Constantino, N. E. (2019). Calidad de atención y satisfacción del usuario externo en el servicio de hospitalización del hospital José Soto Cadenillas chota, 2018. *Universidad Nacional de Cajamarca*. <http://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/3355>

Paredes Larios, C. del P. (2019). Calidad de atención y satisfacción del usuario externo del centro de salud Cañaris, 2019. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/72043>

Repetto Tkachenko, L. V. (2022). Calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Centro de Salud Mental Comunitario de La Perla, 2021. *Repositorio Institucional* - UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/85428>

Vélez, S. & González, Y. (2021). Calidad de la atención de los servicios de salud en Colombia en los últimos diez años. *Universidad de Antioquia Facultad Nacional de Salud Pública, Antioquia Medellín*, Tesis o trabajo de grado optar al título de Auditor en Salud.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESTUDIO: CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL
COMUNITARIO VILLA CAMPOY, 2025

Lo invitamos a participar en un estudio para conocer la relación entre la Calidad de Atención y Satisfacción del usuario del centro de salud mental comunitario Villa Campoy, 2025. Su participación es voluntaria, sin algún costo monetario, libre de coacción e influencia indebida y libertad de terminar su participación cuando lo considere. Usted tiene la libertad de hacer las preguntas que considere, tomarse el tiempo necesario para decidir su participación, llevarse una copia del formulario si lo desea. La calidad de la salud mental se define como el grado en que los servicios de salud satisfacen las necesidades, las expectativas y los estándares de atención de la persona, sus familias y otros beneficiarios de la atención. Los factores fundamentales en cuanto a la calidad de la atención son la visión de la persona sobre la atención prestada, el resultado del tratamiento, la actitud del personal, el ambiente o infraestructura y el servicio de salud mental. La Satisfacción del Usuario Externo es el juicio de valor emitido de acuerdo con la percepción del individuo en relación con las condiciones de las áreas físicas y características del servicio recibido. Precisan que la satisfacción del usuario se refiere al conjunto de actitudes y comportamientos hacia un objetivo particular. Por ello nuestro objetivo principal es determinar la relación entre la Calidad de Atención y Satisfacción del usuario de los pacientes del centro de salud mental comunitario para generar conocimiento y se puedan dar las mejoras en el establecimiento. Si decide participar en este estudio se aplicará dos cuestionarios uno que consta de 22 preguntas y el otro cuestionario consta de 14 preguntas, ambos de fácil llenado. El estudio tomará alrededor de 15 minutos de su tiempo. Se le informará sobre los resultados que se obtengan de la investigación, comunicarse con el investigador a través del correo. Además, se recolectará datos en una encuesta como: edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, condición laboral, ocupación, tiempo de servicio. Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Sólo los investigadores tendrán acceso a las bases de datos. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al investigador del estudio en cualquier momento.

Al firmar este documento está diciendo que:

Está de acuerdo con participar en el estudio.
Le hemos explicado la información que contiene este documento y hemos contestado todas sus preguntas.

Usted sabe que:

No tiene que contestar preguntas que no quiera contestar.
En cualquier momento, puede dejar de contestar nuestras preguntas y no le pasará nada a usted.
Puede llamar a la oficina encargada de investigaciones al [incluya número de teléfono] si tiene alguna pregunta sobre el estudio o sobre sus derechos.

HE LEÍDO Y COMPRENDIDO. HE QUEDADO SATISFECHO. MIS PREGUNTAS HAN SIDO RESPONDIDAS.

YO, VOLUNTARIAMENTE PERMITO LA PARTICIPACIÓN DE MI MENOR HIJO, EN EL ESTUDIO.
Lima,..... de.....del 2025.

Firma del Participante
Apellidos y nombres
DNI

Firma del testigo
Apellidos y nombres del apoderado
DNI

Firma del Responsable del estudio

ENCUESTA

1. Nro. de Historia Clínica: _____

2. Lugar de procedencia: Campoy = 1 Zarate = 2 Caja de Agua = 3

3. Edad: Menos de 25 años = 0 25 - 30 años = 1 31 - 36 años = 2

37- 42 años = 3 Más de 42 años = 4

4. Sexo: Femenino = 0 Masculino = 1

5. Nivel Socioeconómico: Baja = 0 Media = 1 Alta = 3

6. Grado de instrucción Analfabeto = 0

Primaria = 1

Secundaria = 2

Superior = 3

7. Tipo de diagnóstico

Ansiedad = 1 Depresión = 2 Esquizofrenia Paranoide = 3

Adicciones = 4 Violencia = 5

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUESTIONARIO DE CALIDAD DE ATENCIÓN

Lea atentamente cada ítem y marque con una (X) la alternativa que usted crea conveniente, asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo con su apreciación personal.

A continuación, se presenta la escala de medición:

	1	2	3	4	5
	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
	ITEMS				
	1	2	3	4	5
1	La atención se realizó sin diferencia alguna en relación con otras personas				
2	La atención se realizó en orden y respetando el orden de llegada				
3	La atención se realizó según el horario publicado en el CSMC				
4	Cuentan con mecanismos para presentar quejas o reclamos				
5	La farmacia cuenta con los medicamentos que recetó el médico				
6	La atención en el área de farmacia es rápida				
7	La atención en el área de admisión es rápida				
8	El tiempo de espera para ser atendido en el consultorio es corto				
9	Cuando presente algún problema se resuelve inmediatamente				
10	Durante su atención en el consultorio se respeta su privacidad				
11	El médico u otro profesional que le atendió le realizó un examen completo y minucioso				
12	El médico u otro profesional que le atendió, le brindó el tiempo suficiente para contestar sus dudas o preguntas				
13	El médico u otro profesional que lo/la atendió le inspiró confianza				
14	El médico u otro profesional lo/la trató con amabilidad, respeto y paciencia				
15	El personal de farmacia lo/la trató con amabilidad, respeto y paciencia				
16	El personal de admisión lo/la trató con amabilidad, respeto y paciencia				
17	Usted comprendió la explicación que le brindó el médico u otro profesional sobre su salud o resultado de la atención				
18	Usted comprendió la explicación que el médico u otro profesional le brindó sobre el tratamiento que recibirá y los cuidados para su salud				
19	Los carteles, letreros o flechas del establecimiento son adecuados para orientar a los pacientes				
20	El consultorio y la sala de espera se encuentran limpios y cuentan con mobiliario (bancas y sillas) para comodidad de los pacientes				
21	El establecimiento de salud cuenta con baños limpios para los pacientes				
22	Los consultorios cuentan con equipos disponibles y materiales necesarios para su atención				

Cuestionario de Satisfacción del usuario de consulta externas (SUCE)

Marcar en el casillero que va del 1 al 5 las siguientes situaciones percibidas en este Centro de Salud Mental Comunitario. Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación. Este cuestionario nos ayudaran a mejorar como institución las atenciones a nuestros usuarios. Agradecemos su participación.

A continuación, se presenta la escala de medición:

1	2	3	4	5
Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre

	ITEMS	1	2	3	4	5
1	El lapso de espera entre la solicitud de la cita y la cita fue apropiado					
2	Las señalizaciones y carteles son eficientes para orientarse dentro del establecimiento de salud					
3	Las solicitudes para inicio de trámite son atendidas de manera oportuna					
4	Me siento cómodo/a con el tiempo de espera en consulta					
5	La sala de espera es cómoda durante la espera					
6	Tener una segunda cita corresponde a un trámite fácil de realizar					
7	El trato por parte del personal de psicología es apropiado					
8	El trato por parte del personal médico es apropiado					
9	Durante la consulta me he visto expuesto a una situación incómoda					
10	La duración de la consulta ha sido suficiente para atender mi problema					
11	La información clínica que obtuve ha satisfecho la preocupación sobre mi salud					
12	La explicación del tratamiento e indicaciones a seguir ha sido clara					
13	La atención obtenida en consulta externa ha sido satisfactoria					
14	¿Conoce el nombre del médico que le atiende en consulta?	SI		NO		

ESTUDIO PILOTO

CALIDAD DE ATENCIÓN

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
C1	.396	30	.000	.609	30	.000
VAR00002	.517	30	.000	.404	30	.000
VAR00003	.386	30	.000	.681	30	.000
VAR00004	.434	30	.000	.567	30	.000
VAR00005	.508	30	.000	.416	30	.000
VAR00006	.537	30	.000	.275	30	.000
VAR00007	.429	30	.000	.623	30	.000
VAR00008	.345	30	.000	.780	30	.000
VAR00009	.315	30	.000	.739	30	.000
VAR00010	.528	30	.000	.347	30	.000
VAR00011	.353	30	.000	.608	30	.000
VAR00012	.476	30	.000	.515	30	.000
VAR00013	.405	30	.000	.656	30	.000
VAR00014	.508	30	.000	.416	30	.000
VAR00015	.508	30	.000	.416	30	.000
VAR00016	.423	30	.000	.626	30	.000
VAR00017	.457	30	.000	.554	30	.000
VAR00018	.446	30	.000	.594	30	.000
VAR00019	.462	30	.000	.559	30	.000
VAR00020	.517	30	.000	.404	30	.000
VAR00021	.416	30	.000	.632	30	.000
C22	.444	30	.000	.513	30	.000
a. Lilliefors Significance Correction						

En la tabla observamos, tanto el valor-p de Kolmogorov-Smirnov como el de Shapiro-Wilk es 0.000, lo que indica que: Se rechaza la hipótesis nula de normalidad y por lo tanto, las variables siguen una distribución no normal por lo que se utilizará el estadístico Rho Spearman para pruebas no paramétricas.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Tests of Normality						
Double-click to activate	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
S1	.282	30	.000	.767	30	.000
VAR00024	.473	30	.000	.526	30	.000
VAR00025	.446	30	.000	.594	30	.000
VAR00026	.335	30	.000	.722	30	.000
VAR00027	.371	30	.000	.701	30	.000
VAR00028	.389	30	.000	.624	30	.000
VAR00029	.494	30	.000	.471	30	.000
VAR00030	.528	30	.000	.347	30	.000
VAR00031	.371	30	.000	.585	30	.000
VAR00032	.360	30	.000	.700	30	.000
VAR00033	.353	30	.000	.608	30	.000
VAR00034	.488	30	.000	.492	30	.000
VAR00035	.457	30	.000	.554	30	.000
S14	.517	30	.000	.404	30	.000
a. Lilliefors Significance Correction						

En la presente tabla se observa que, tanto el valor-p de Kolmogorov-Smirnov como el de Shapiro-Wilk es 0.000, lo que indica que: Se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Por tanto, las variables siguen una distribución no normal por lo que se utilizará el estadístico Rho Spearman

CALIDAD DE ATENCIÓN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	22

En la table se presenta de 30 casos fueron válidos (96.8%) para el análisis de fiabilidad. 1 caso fue excluido (3.2%) por contener valores perdidos en alguna de las variables incluidas. El alfa de Cronbach obtenido es 0.821, lo cual indica una buena consistencia interna. El instrumento (escala) con 22 ítems tiene una buena fiabilidad en cuanto a consistencia interna ($\alpha = 0.821$).

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded ^a	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.659	14

En la table se presenta de 30 casos fueron válidos (96.8%) para el análisis de fiabilidad. 1 caso fue excluido (3.2%) por contener valores perdidos en alguna de las variables incluidas. El valor del Alfa de Cronbach es 0.659, lo que indica una consistencia interna marginal o baja. El instrumento tiene 14 ítems tiene una fiabilidad baja ($\alpha = 0.659$).